

דום לב ונשימה VT/VF



◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-גרמי



האם יש התוויה למתן שוק חשמלי?

לא

כן



◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אדרנלין כל 3-5 דקות ¹
◀ שקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר



האם יש התוויה למתן שוק חשמלי?

לא

כן



◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אמיודרון ב-1V ²
◀ שקול צורך בטיפול תרופתי נוסף ³
◀ טפל בגורמים הפיכים ⁵

לא

מצב של חזרת דופק ספונטני?
ROSC ⁴

כן

עבור לפרוטוקול
מתאים ⁶

עבור לפרוטוקול
הטיפול בחולה לאחר
החייאה (ROSC)

יש עדיפות למתן תוך-ורידי של תרופות במהלך החייאה.
במקרה של כישלון – יש להתקין I.O ולתת את התרופות תוך-גרמית.

השוק החשמלי

- + מכשיר 12-LP – 360J > 300J > 200J
- + מכשיר Corplus – 200J
- + הקפד על מיקום נכון של מדבקות הדפיברילציה.
- + לאחר שלושה שוקים חשמליים ללא שינוי בקצב עבור ל-Refractory VT/VF.

1 אדרנלין

- + מנה ראשונה תינתן רק לאחר שני סבבים.
- + מינון ב-1 mg I.V (כל 3-5 דקות).
- + יש לתת מייד בולוס של 20 ml סליין.
- + מינון ב-E.T – 3 mg מהולים ב-5 ml סליין.

2 אמיודרון

- + מנה ראשונה – 300 mg.
- + מנה שנייה – 150 mg.
- + מיהול – 20 ml.

3 טיפול תרופתי נוסף –

מגנזיום סולפט

- + מתן רק במקרים של טכיקרידיה רחבת קומפלקס ופולימורפית (TDP).
- + מינון – 1-2 gr.
- + מיהול – ב-10-20 ml תמיסת סליין.
- + מתן ב-PUSH איטי.

סודיום ביקרבונט

- + מינון 1 meq/kg

...

תוכן עניינים > כללי : פרק 2

+ אינדיקציה למתן עדות מוקדמת להיפרקלמיה או לחמצת מטבולית.

4 ROSC

- + חזרת דופק מרכזי או פריפרי.
- + עלייה חדה בערכי ETCO₂ (לרוב ערכים מעל 40 mmHg).
- + אם נמוש דופק פריפרי יש למדוד לחץ דם.
- + שקול צורך בטיפול תרופתי נוסף.

5 טיפול בגורמים הפיזיים

- + הרעלת אופיאטים – מתן נרקן.
- + היפוולמיה – מתן נוזלים.
- + היפותרמיה – חימום הסביבה.
- + היפוקסיה – מתן חמצן בריכוז מרבי.
- + היפרקלמיה או חמצת מטבולית – מתן סודיום ביקרבונט.
- + חזה אוויר בלחץ – ניקוז חזה באמצעות מחט (NA).

זונדה

- + הכנס זונדה למטופל שעבר הנשמה ממושכת ללא טובוס ויש חשד קליני להתרחבות הקיבה.

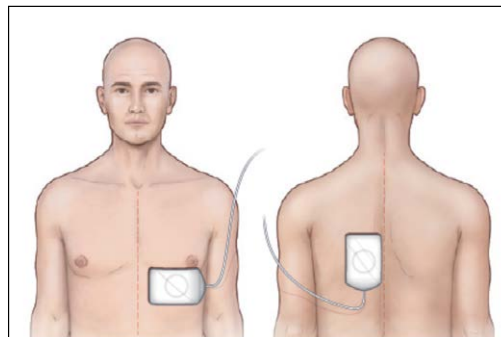
6 פרוטוקול מתאים –

דום לב במבוגר PEA/ASYSTOLE

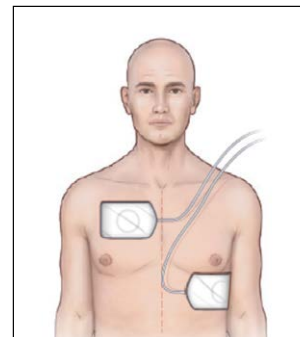
פינוי מטופל לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה
הימנעות מביצוע פעולות החייאה או הפסקתן

Refractory VT/VF

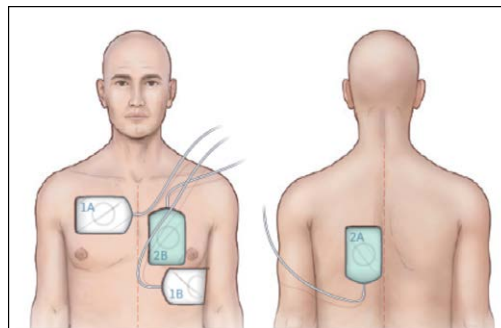
- + **הגדרה** – ללא שינוי בהפרעת הקצב לאחר 3 מכות חשמל (כולל שימוש ב־AED).
- + **טיפול** – החל מסבב רביעי ביצוע דפיברילציה בטכניקה מתקדמת (VC או DSED).
- + **Double Sequential External Defibrillation (DSED)** – מתן 2 מכות חשמל עוקבות, בהפרש של 0.12 msec, מ־2 מכשירים שונים המחוברים בוקטורים צולבים (ראה איור). זוהי הטכניקה המועדפת.
- + **Vector Change (VC)** – מתן מכת חשמל בוקטור ניצב לוקטור הרגיל (קרי – כאשר מדבקה אחת מעל האפקס מלפנים והמדבקה השניה בנקודה מקבילה בגב מאחור – ראה איור).



Vector Change Defibrillation



Standard Defibrillation



Double Sequence External Defibrillation